

Zahnimplantate – Beratung und Behandlung

Implantate verstehen

Das Wichtigste vorab

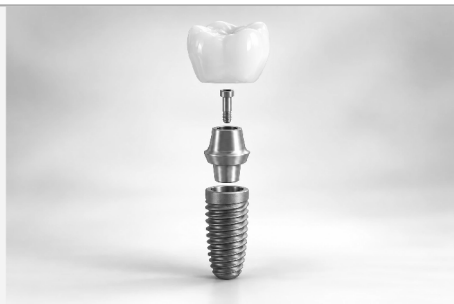
- Das Implantat ersetzt die Wurzel; Krone, Brücke oder Prothese werden separat geplant.
- Beim Ersttermin wird beraten und untersucht, nicht implantiert.
- Der gewünschte Zahnersatz bestimmt die Planung; zusätzlicher Knochenaufbau ist befundabhängig.
- Chirurgie und Hauszahnarztpraxis arbeiten zusammen und rechnen ihre Leistungen getrennt ab.
- Heilung, passende Belastung, Reinigung und Nachsorge sind Teil der Behandlung.

Ein Implantat ersetzt eine fehlende Zahnwurzel. Diese gemeinsame Information begleitet Sie von den ersten Fragen über die Beratung und Planung bis zur Behandlung und langfristigen Pflege. Sie ergänzt das persönliche Aufklärungsgespräch; welche Schritte für Sie geeignet sind, entscheiden wir nach Untersuchung und gemeinsamer Abwägung.

Implantat, Aufbau und Zahnersatz

Der Implantatkörper wird im Kieferknochen verankert. Ein Verbindungsstück trägt später die sichtbare Krone, Brücke oder Prothese. Ein Implantat ist also noch kein vollständiger Zahn. Wir übernehmen die chirurgische Planung und Behandlung in Abstimmung mit Ihrer Hauszahnarztpraxis; dort wird die definitive prothetische Versorgung geplant und hergestellt.

Titan ist in unserer Praxis der bewährte Standard. Keramik kann in ausgewählten Situationen eine Alternative sein; Eigenschaften, Grenzen und Kosten werden individuell besprochen. Größe und Anzahl der Implantate richten sich nach Knochenangebot und geplantem Zahnersatz. Informieren Sie bei einer MRT-Untersuchung die Radiologie über Ihre Implantate.



Aufbau eines Zahnimplantats in Explosionsdarstellung: oben die Krone, darunter die innenliegende Prothetischschraube, das Verbindungsstück (Abutment) und der Implantatkörper. Die Schraube befestigt das Abutment im Implantat. KI-generierte Schemazeichnung, keine Patientenaufnahme.

Welche Versorgung ist möglich?

- Einzelne Zahnücke: Ein Implantat trägt eine Krone; gesunde Nachbarzähne müssen dafür üblicherweise nicht beschliffen werden.
- Größere Lücke: Mehrere Implantate können eine Brücke tragen. Nicht jeder fehlende Zahn benötigt ein eigenes Implantat.
- Zahnloser Kiefer: Implantate können herausnehmbaren Zahnersatz stabilisieren oder eine festsitzende Versorgung ermöglichen.
- Bei späteren Veränderungen kann ein geeignetes Implantat gegebenenfalls in eine neue Versorgung einbezogen werden.

Alternativen gemeinsam abwägen

Eine Brücke, herausnehmbarer Zahnersatz oder in ausgewählten Situationen das Belassen einer Lücke können Alternativen sein. Eine Brücke kann besonders dann sinnvoll sein, wenn Nachbarzähne ohnehin eine Krone benötigen. Aufwand, Reinigung, Zustand der Nachbarzähne, Kosten und Ihre Wünsche zählen zur Entscheidung. Ein erhaltungswürdiger eigener Zahn wird nicht allein wegen der Möglichkeit eines Implantats entfernt.

Implantatgröße, Material und Verträglichkeit

Wie groß ist ein Implantat?

Als Größenbeispiel können Sie sich etwa 4 mm Durchmesser und 8–10 mm Länge vorstellen. Das ist keine feste Vorgabe: Es gibt kürzere, längere, schmalere und breitere Implantate. Knochenangebot, Zahnposition und Belastung bestimmen die Auswahl. Ein Implantat ist häufig zweiteilig: Der Körper trägt außen das Knochengewinde, innen nimmt er das mit einer Prothetikschrube befestigte Abutment auf.

Warum verwenden wir überwiegend Titan?

Titan ist unser bewährter Standard mit umfangreicher Langzeiterfahrung und vielen chirurgischen sowie prothetischen Gestaltungsmöglichkeiten. Der Knochen lagert sich an die Oberfläche an; diese feste Verbindung heißt Osseointegration. Bei unserem üblichen Vorgehen heilt der Implantatkörper zunächst geschützt unter der Schleimhaut ein.

Wann kommt Keramik infrage?

Zirkonoxid-Keramik kann bei geeigneter Situation eine Alternative sein, beispielsweise bei Wunsch nach einer metallfreien Versorgung. Besprochen werden das konkrete ein- oder zweiteilige System, Belastbarkeit, Bruchrisiken, prothetische Möglichkeiten, Kombination mit Knochenaufbau und Kosten. Einschränkungen sind systemabhängig; nicht jeder Nachteil lässt sich pauschal auf alle Keramikimplantate übertragen. In unserer Praxis können gegenüber Titan höhere Kosten entstehen. Für Titan besteht die breitere Langzeiterfahrung; für ausgewählte Keramiksyste me liegen ebenfalls gute klinische Ergebnisse vor. [2]

Wird ein Implantat abgestoßen?

Eine Abstoßung wie nach einer Organtransplantation ist nicht die typische Erklärung für einen Implantatverlust. Mögliche Ursachen sind fehlende Einheilung, Infektion, unzureichender Knochen, Überlastung oder ungünstige Pflegebedingungen. Bei Verdacht auf eine Materialunverträglichkeit klären wir die Beschwerden gezielt ab; ein Verlust allein beweist keine Allergie.

Kann ich mit einem Implantat zur MRT?

Titan ist nicht ferromagnetisch. Eine MRT ist mit vielen dentalen Implantaten möglich, entscheidend sind aber die Angaben zum konkreten Implantat und zu weiteren Komponenten. Informieren Sie die Radiologie und bringen Sie möglichst Ihren Implantatpass mit. Metall kann die Bildqualität in seiner Umgebung beeinträchtigen; die Freigabe der Untersuchung erfolgt durch die Radiologie.

Implantat, Brücke oder herausnehmbarer Zahnersatz

Der erhaltungswürdige eigene Zahn hat Vorrang. Bei einer Zahnlücke vergleichen wir die Möglichkeiten anhand Ihres Befunds und Ihrer Wünsche; keine Lösung ist für alle Menschen die beste.



Links: Eine implantatgetragene Einzelkrone ersetzt den fehlenden Zahn, ohne die Nachbarzähne zu beschleifen. Rechts: Eine konventionelle Brücke wird von den präparierten Nachbarzähnen getragen. Schematische Darstellung.

Kriterium	Implantat	Konventionelle Brücke	Teilprothese
Nachbarzähne	Müssen meist nicht beschliffen werden.	Pfeilerzähne werden in der Regel beschliffen; sinnvoll bei bereits überkronungsbedürftigen Zähnen.	Halte- und Stützelemente beziehen oft andere Zähne ein.
Halt und Reinigung	Feste Einzelversorgung möglich; Zwischenräume gezielt reinigen.	Fest; unter dem Brückenglied mit geeigneten Hilfsmitteln reinigen.	Herausnehmbar; Prothese und Restzähne reinigen.
Knochen und Komfort	Überträgt Kräfte in den Knochen; verhindert Knochenveränderungen nicht vollständig.	Ersetzt die fehlende Wurzel nicht; Komfort hängt von Ausführung und Pfeilern ab.	Ersetzt die fehlende Wurzel nicht; Halt und Komfort hängen vom Konzept ab.
Aufwand und Dauer	Chirurgie und mehrere Monate Heilung; gegebenenfalls Knochenaufbau.	Oft in wenigen Wochen, beispielsweise 4–8 Wochen, wenn die Voraussetzungen vorliegen.	Oft in wenigen Wochen, beispielsweise 4–8 Wochen; Vorbehandlungen können verlängern.

Alle Versorgungen können Pflege, Reparaturen oder späteren Ersatz benötigen. Wird eine Lücke belassen, können sich Zähne verschieben, Gegenzähne herauswachsen und die Belastung verändern; Ausmaß und Behandlungsbedarf beurteilen wir individuell. Eine Lücke muss nicht in jedem Fall mit einem Implantat versorgt werden.

Ihr erster Beratungstermin

Beim Ersttermin wird untersucht, besprochen und geplant – nicht implantiert. Sie müssen die Spezialverfahren vorher nicht kennen. Der Termin verpflichtet Sie nicht zur Behandlung. Wir klären Ihre Wünsche, medizinische Eignung, Alternativen und den voraussichtlichen zeitlichen und finanziellen Rahmen.

Bitte mitbringen

- Aktuellen Medikamentenplan einschließlich frei verkäuflicher Mittel und Nahrungsergänzungsmittel.
- Allergiepass und vorhandene Röntgenbilder, OPG oder DVT; neue Aufnahmen bitte nicht allein auf Verdacht veranlassen.
- Überweisung oder Fragestellung Ihrer Hauszahnarztpraxis sowie Informationen zum gewünschten Zahnersatz.
- Vorhandene Prothese oder Provisorium, Angaben zu Versicherung und gegebenenfalls Zusatzversicherung.

Bitte vorher mitteilen

- Rauchen, Diabetes (HbA1c-Wert, falls bekannt), Parodontitis sowie frühere Implantatverluste oder Wundheilungsstörungen.
- Blutverdünner oder gerinnungshemmende Medikamente wie ASS, Marcumar oder direkte orale Antikoagulanzen.
- Aktuelle oder frühere Einnahme von Bisphosphonaten oder Denosumab; möglichst Präparat, Dauer und letzte Anwendung angeben.
- Immunsuppression, Kortison, Chemo- oder Strahlentherapie, insbesondere im Kopf-Hals-Bereich; relevante Herz-Kreislauf-Erkrankungen und kürzliche größere Eingriffe.
- Allergien, mögliche Schwangerschaft sowie starkes Knirschen oder Pressen.

Dauermedikamente nicht selbst absetzen oder umstellen. Ob eine Anpassung nötig ist, stimmen wir abhängig von Medikament, Eingriff und Erkrankung mit Ihnen und gegebenenfalls dem behandelnden Arzt ab. Eine INR-Messung ist nicht für jedes gerinnungshemmende Medikament geeignet.

Ihre Fragen sind Teil der Planung

Was stört Sie aktuell? Wünschen Sie festen oder herausnehmbaren Zahnersatz? Welche Rolle spielen Behandlungsdauer, Angst, Provisorium und Kosten? Bringen Sie Ihre Fragen gerne mit. Das Lebensalter allein entscheidet nicht über die Eignung; Gesundheit, abgeschlossene Kieferentwicklung, Pflegefähigkeit und Behandlungsziel sind maßgeblich.

Erstberatung und persönliche Risikofaktoren

Was geschieht beim ersten Termin?

Wir besprechen Wünsche, Befund, Alternativen und Risikofaktoren, untersuchen die Mundsituation und prüfen vorhandene Röntgenbilder. Erst dann entscheiden wir, ob zusätzliche Bildgebung nötig ist. Sie erhalten eine erste Einschätzung zu Behandlung, Zeit und Kosten; der konkrete Plan folgt nach ausreichender Diagnostik. Eine Planungssitzung kann etwa 30 Minuten benötigen, bei komplexen Fragen länger. Beim Ersttermin wird nicht implantiert; Sie können die Entscheidung in Ruhe treffen.

Welche Erkrankungen und Medikamente sind besonders wichtig?

Bitte nennen Sie auch kürzliche Herzinfarkte, Schlaganfälle, Stentbehandlungen und größere Operationen. Allergien auf Antibiotika, Schmerz- oder Betäubungsmittel, mögliche Schwangerschaft sowie alle frei verkäuflichen Mittel und Nahrungsergänzungen gehören ebenfalls zur Anamnese.

- **Gerinnungshemmung:** beispielsweise ASS, Clopidogrel, Marcumar oder direkte orale Antikoagulanzen wie Xarelto, Eliquis, Lixiana oder Pradaxa. Änderungen nur nach Abstimmung. Ein INR-Wert ist insbesondere für Vitamin-K-Antagonisten relevant, nicht als allgemeiner Test für alle Blutverdünner.
- **Bisphosphonate oder Denosumab:** auch frühere Behandlung, Präparat, Dosierung, Grund, Dauer und letzte Gabe mitteilen. Das Risiko einer Kieferknochennekrose hängt unter anderem von der Therapieform ab; Absetzen beseitigt das Risiko nicht automatisch.
- **Diabetes:** letzten HbA1c-Wert mitbringen, falls bekannt. Bei schlechter Einstellung, beispielsweise Werten über etwa 8 % (64 mmol/mol), prüfen wir eine vorherige Optimierung. Ein Einzelwert ist keine automatische allgemeine Ausschlussgrenze.
- **Parodontitis, Karies und Entzündungen:** vor der Implantation behandeln und stabilisieren; gute Pflegefähigkeit muss erreichbar sein.
- **Immunsuppression, Kortison, Chemo- oder Kopf-Hals-Bestrahlung:** können Heilung und Infektionsrisiko beeinflussen; gegebenenfalls stimmen wir uns mit den behandelnden Ärzten ab.

Bin ich zu alt?

Das Alter allein entscheidet nicht. Allgemeinzustand, Medikamente, Belastbarkeit, Knochenangebot und die spätere Pflege sind wichtiger. Auch Menschen über 90 Jahre wurden in unserer Praxis bei geeigneter Ausgangslage versorgt. Umgekehrt kann eine einfachere Lösung bei eingeschränkter Belastbarkeit sinnvoller sein. Bei jungen Menschen muss das Kieferwachstum abgeschlossen sein.

Digitale Implantatplanung

Wir planen vom gewünschten Zahnersatz aus rückwärts: Zuerst wird die spätere Zahnposition digital simuliert. Daraus ergeben sich die sinnvolle Implantatposition und die Frage, ob zusätzlicher Knochen benötigt wird. Dieses Vorgehen heißt Backward Planning.

Vom prothetischen Setup zur Operation

- Untersuchung und Scan beziehungsweise Modelle erfassen Zähne, Zahnfleisch, Biss und verfügbaren Platz.
- Die gewünschte Krone, Brücke oder Prothese wird mit der Hauszahnarztpraxis abgestimmt und digital geplant, beispielsweise anhand der Gegenseite oder einer Zahndatenbank.
- Anhand geeigneter Röntgenbilder beurteilen wir Knochen, Nachbarzähne, Unterkiefernerve und gegebenenfalls Kieferhöhle.
- Wenn erforderlich, übertragen individuell gefertigte Bohr- und Positionierungsschablonen die Planung in die Operation. Auch eine Schablone ersetzt nicht die operative Kontrolle und beseitigt Risiken nicht vollständig.

Ist immer eine DVT nötig?

Nein. Vorhandene beziehungsweise konventionelle Aufnahmen können für eine klar beurteilbare Situation ausreichen. Eine DVT setzen wir ein, wenn die dreidimensionale Information die Diagnostik oder sichere Planung wesentlich unterstützt. Nutzen, Strahlenbelastung und zusätzliche Kosten erklären wir vor der Aufnahme.

Ist vor der Implantation ein Knochenaufbau erforderlich?

Damit ein Implantat stabil und in der für den späteren Zahnersatz passenden Position eingesetzt werden kann, muss ausreichend Knochen vorhanden sein. Fehlt Knochen in der Breite oder Höhe, können wir ihn gezielt aufbauen. Kleine Defekte lassen sich unter geeigneten Bedingungen gleichzeitig mit der Implantation aufbauen. Bei größerem Höhen- oder Breitenmangel ist häufig zunächst ein eigener Knochenaufbau mit anschließender Heilungsphase erforderlich. Im hinteren Oberkiefer kann ein Sinuslift infrage kommen. Eine Brücke, Prothese oder andere Implantatplanung kann im Einzelfall eine Alternative zu einem aufwendigen Aufbau sein.

Die passende Technik wird erst nach Befund festgelegt. Sie erhalten dann die zu Ihrem Verfahren gehörende Detailinformation; nicht alle Aufbauverfahren müssen vorab gelesen werden.

Schablonenfertigung in unserer Praxis

Wenn eine schablonengeführte Behandlung vorgesehen ist, können wir die digitale Planung in individuell gefertigte, 3D-gedruckte und für die Aufbereitung geeignete Bohr- und Positionierungsschablonen übertragen. Dieses Verfahren ist bei uns seit mehreren Jahren etabliert. Eine medizinisch vertretbare Positionsanpassung kann im Einzelfall den Aufbauaufwand verringern; entscheidend bleibt die spätere prothetische Versorgung.

Welche Behandlungswege kommen infrage?

Diese Übersicht dient der Orientierung vor der Entscheidung. Welche Methode erforderlich ist, wird nach Untersuchung und Planung festgelegt. Knochen wird gezielt dort aufgebaut, wo er für die geplante Versorgung fehlt.

A · Implantat ohne Aufbau

Breite und Höhe des Knochens reichen aus. Es folgen Implantation, Einheilung, gegebenenfalls Freilegung und die Versorgung beim Hauszahnarzt.

B · Kleiner gleichzeitiger Aufbau

Das Implantat ist stabil einsetzbar, kleinere Defekte werden gleichzeitig mit Knochenspänen, gegebenenfalls Knochenersatzmaterial und Membran ergänzt. Sticky Bone kann für kleinere Restdefekte infrage kommen.

C/D · Interner oder externer Sinuslift

Im seitlichen Oberkiefer wird bei Bedarf die Kieferhöhlenschleimhaut angehoben. Intern erfolgt der Zugang durch das Implantatlager, extern über ein seitliches Knochenfenster. Je nach Restknochen und Stabilität wird gleichzeitig implantiert oder zunächst der Aufbau eingeheilt.

E · Schalenteknik

Dünne eigene Knochenschalen werden mit kleinen Schrauben fixiert und schaffen einen geschützten Raum, der mit Knochenspänen gefüllt wird. Bei größeren vertikalen Defekten erfolgt dies in der Regel vor der Implantation. Eigenknochen wird häufig aus dem hinteren Unterkiefer gewonnen.

F · Semilunartechnik

Eine gebogene eigene Knochenschale aus dem hinteren Unterkiefer wird ausgedünnt und mit kleinen Schrauben über dem Defekt befestigt. Der Raum darunter wird mit Knochenspänen aufgefüllt. Entnahme und Material passen wir dem Befund an.

G · Titanverstärkte PTFE-Membran

Eine formstabile Membran schützt den Aufbau und hält den Raum für die Knochenbildung offen. Membran und Fixierung werden später planmäßig entfernt. Ob zusätzlich Eigenknochen entnommen werden muss, hängt vom gewählten Aufbau ab.

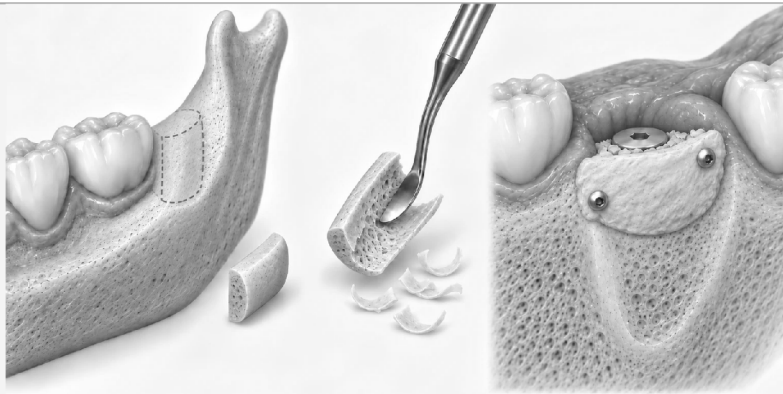
H · Alternative zum aufwendigen Aufbau

Eine andere vertretbare Implantatposition, ein kürzeres Implantat, eine Brücke, Prothese oder der Verzicht auf einen größeren Eingriff können je nach Befund sinnvoller sein. Risiko, Nutzen, Prognose und Kosten werden gemeinsam abgewogen.

Aufbauprinzipien im Bild



Schalentechnik: stabiler Raum für einen größeren Aufbau. KI-generiertes Schema, keine Patientenaufnahme.



Semilunarschale: gebogene eigene Knochenschale über dem Defekt. KI-generiertes Schema, keine Patientenaufnahme.



Titanverstärkte PTFE-Membran: Schutz und Raumhaltung. KI-generiertes Schema, keine Patientenaufnahme.

Ihr Zeitplan: von der Zahnentfernung zum Zahnersatz

Die Behandlung besteht aus mehreren Terminen und biologischen Heilungsphasen. Dieses Beispiel zeigt unseren häufigen Ablauf nach einer Zahnentfernung; die Zeitangaben sind keine festen Termine.

1 Nach der Zahnentfernung

Etwa 8 Wochen Abheilung

Die Schleimhaut schließt sich, das Gewebe beruhigt sich. Beratung kann auch früher stattfinden; die definitive Planung erfolgt bei uns häufig nach etwa acht Wochen, wenn der Befund geeignet ist.

2 Untersuchung und Planung

Häufig um Woche 8 nach Extraktion

Wir prüfen Knochen und Zahnfleisch und planen die spätere Krone beziehungsweise Prothese. Scan, gegebenenfalls DVT, Kostenplan und nötige Schablonen werden vorbereitet.

+

NUR FALLS ERFORDERLICH · ZUSÄTZLICHER SCHRITT

Knochenaufbau vor der Implantation

Häufig 4–6 Monate zusätzliche Einheilzeit

Bei größeren Höhen- oder Breitenverlusten, insbesondere beim vertikalen Aufbau mit Schalentchnik, bauen wir zuerst den Knochen auf. Nach der Einheilung prüfen wir, ob die Implantation möglich ist. Beim Sinuslift hängt ein gleichzeitiges oder getrenntes Vorgehen vom Restknochen und Befund ab.

Danach weiter mit Schritt 3 · Ohne Voraufbau direkt zu Schritt 3

3 Implantation

Ohne Voraufbau: im Beispiel etwa 2 Wochen nach Planung

Bei passendem Befund und abgeschlossener Vorbereitung kann die Implantation etwa in Woche zehn nach der Extraktion erfolgen. Die zwei Wochen sind Planungszeit, keine vorgeschriebene Heilungsfrist. Ein kleiner Knochenaufbau kann gleichzeitig erfolgen. Nach vorgelagertem Aufbau findet dieser Schritt erst nach dessen Einheilung und Freigabe statt.

4 Implantat geschützt einheilen lassen

Häufig 3–4 Monate ab Implantation

Der Knochen verbindet sich mit der Implantatoberfläche. Bei Knochenaufbau oder erschwerter Heilung kann es länger dauern. Nicht auf die operierte Stelle beißen; auch ein Provisorium darf keinen Druck ausüben. Kontrollen und Nahtentfernung nach individuellem Plan.

5 Freilegung und Zahnfleischheilung

Danach häufig etwa 4 Wochen

Nach bestätigter Einheilung öffnen wir bei gedeckter Heilung das Zahnfleisch und setzen einen Gingivaformer ein. Er formt den Zahnfleischnachwuchs; er ist noch kein fertiger Zahn. Diese Weichgewebeheilung ist eine eigene Phase.

6 Scan oder Abdruck und Zahnersatz

Anschließend bei Ihrer Hauszahnarztpraxis

Nach unserer Freigabe folgen Scan oder Abdruck, Herstellung und Einprobe der Krone, Brücke oder Prothese. Hierfür kommen weitere Termine und die Fertigungszeit hinzu; die Hauszahnarztpraxis stimmt diese mit Ihnen ab.

Gesamtdauer richtig einordnen: Eine einfache Versorgung dauert häufig etwa **5–6 Monate ab Implantation** bis zum fertigen Zahnersatz. Bei vorgelagertem Aufbau sind häufig etwa **9–12 Monate ab Knochenaufbau** einzuplanen, gegebenenfalls länger. Die Abheilung nach Extraktion und die Planung davor kommen jeweils hinzu.

Ein geschlossener Zahnfleischnachwuchs bedeutet noch nicht, dass der Knochen vollständig eingeeilt ist. Sofortimplantation, offene Einheilung und Sofortversorgung sind eigene Wege für ausgewählte Befunde; der gezeigte Ablauf gilt nicht unverändert für jede Behandlung.

So läuft die Behandlung ab

1 · Vorbereitung und Terminplanung

Vor der Operation werden Entzündungen und gegebenenfalls Parodontitis behandelt, die Mundhygiene verbessert und das Provisorium abgestimmt. Nach einer Zahnentfernung planen wir die Erstvorstellung häufig nach etwa acht Wochen Abheilung. Das ist ein Orientierungswert: Der tatsächliche Implantationszeitpunkt richtet sich nach Weichgewebe, Knochen, Entzündung und Versorgungskonzept. Eine Sofortimplantation ist ein eigener Weg für geeignete Befunde.

2 · Implantation

Unter wirksamer Betäubung wird das Implantatlager vorbereitet, das Implantat eingesetzt und die Wunde versorgt. Ein geplanter kleiner Knochenaufbau kann gleichzeitig erfolgen. Eine einfache Implantation kann häufig etwa 20–30 Minuten Behandlungszeit benötigen; mehrere Implantate und zusätzliche Maßnahmen verlängern den Termin. Ein unerwarteter Befund kann eine Änderung oder ein mehrzeitiges Vorgehen erforderlich machen.

3 · Geschützte Einheilung

Bei unserem üblichen Vorgehen heilt das Implantat zunächst unter der Schleimhaut ein. Die Knochenheilung dauert häufig etwa drei bis vier Monate; bei Aufbau oder ungünstigen Bedingungen länger. Das Operationsgebiet darf nicht durch Aufbeißen oder ein drückendes Provisorium belastet werden. Eine Sofortbelastung ist keine Standardzusage.

4 · Freilegung und Zahnersatz

Nach bestätigter Einheilung wird das Implantat bei gedeckter Heilung in einem kleinen zweiten Eingriff zugänglich gemacht und ein Gingivaformer eingesetzt. Nach der Weichgewebeheilung – häufig etwa vier Wochen – folgen Scan oder Abdruck und die Versorgung durch Ihre Hauszahnarztpraxis. Fäden werden je nach Eingriff und Wundverlauf meist nach ein bis zwei Wochen entfernt; Ihren Termin legen wir individuell fest.

Eine einfache Versorgung benötigt häufig etwa fünf bis sechs Monate ab Implantation bis zur fertigen Krone. Ein vorgelagerter größerer Knochenaufbau kann mehrere zusätzliche Monate erfordern. Diese Zeiten sind Orientierung, keine feste Zusage.

Provisorium, Beruf und Reisen

Eine vorübergehende Zahnversorgung planen wir mit der Hauszahnarztpraxis. Sie muss die Operationsregion entlasten; in besonderen Fällen kommen zusätzliche provisorische Verankerungen infrage. Arbeitsfähigkeit, Sport und Reisen hängen vom Umfang und Heilungsverlauf ab. Planen Sie die Wundkontrollen ein und stimmen Sie Reisen mit eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung vorher ab.

Provisorium und besondere Versorgungssituationen

Muss ich während der Einheilung mit einer Lücke leben?

Die Übergangsversorgung planen wir vor der Operation mit Ihrer Hauszahnarztpraxis. Besonders bei sichtbaren Frontzahnlücken wird in der Regel eine geeignete vorübergehende Lösung angestrebt. Möglich sind je nach Situation herausnehmbare oder befestigte Provisorien. Eine bestimmte Form kann erst nach Prüfung zugesagt werden.

Warum darf das Provisorium nicht drücken?

Frisch operierter Kieferkamm, Aufbau und Implantat müssen geschützt bleiben. Ein Provisorium wird bei Bedarf entlastet oder angepasst; es darf weder auf die Wunde drücken noch das Implantat unzulässig belasten. In einzelnen Fällen muss es vorübergehend weggelassen werden. Melden Sie Druckstellen, statt sie selbst auszuschleifen.

Wann helfen provisorische Implantate?

Bei ausgewählten schwierigen Situationen, etwa ausgedehntem Aufbau oder ungünstigen Verankerungsmöglichkeiten, können zusätzliche provisorische Implantate eine Übergangsprothese stützen. Sie sind ein eigenes, individuell zu planendes Verfahren mit zusätzlichen Eingriffen und Kosten, kein Standard bei jeder Zahnücke.

Sofortimplantat bedeutet nicht automatisch sofort feste Zähne

Eine Sofortimplantation erfolgt am Tag der Zahnentfernung und setzt geeignete Knochenverhältnisse, eine beherrschbare Entzündungssituation und ausreichende Stabilität voraus. Sofortversorgung beziehungsweise Sofortbelastung ist eine zusätzliche, getrennte Entscheidung. Das Risiko hängt von der Auswahl des Falls ab; nicht jede Situation ist dafür geeignet.

Was gilt beim zahnlosen Kiefer?

Hier wird ein Gesamtkonzept für Halt, Zahl und Position der Implantate sowie festen oder herausnehmbaren Zahnersatz benötigt. Implantate können Kauen, Sprechen und Sicherheit verbessern. Ein stabiles vorhandenes Implantat lässt sich bei späteren Veränderungen manchmal als zusätzlicher Pfeiler weiterverwenden; die Verbindung mit eigenen Zähnen muss gesondert geplant werden.

Erholung, Beruf, Sport und Reisen

Diese Vorschau hilft bei Ihrer Terminplanung. Nach der Operation erhalten Sie den ausführlichen Nachsorgebogen und individuelle Anweisungen, insbesondere bei zusätzlichem Knochenaufbau.

Die ersten Tage

Schmerzen, Schwellung, Bluterguss und eingeschränkte Mundöffnung sind möglich. Die Schwellung erreicht häufig um Tag zwei bis drei ihren Höhepunkt und sollte danach allmählich zurückgehen. Blutergüsse können ein bis zwei Wochen sichtbar bleiben. Vorsichtig von außen kühlen, beispielsweise mit einem kühlen feuchten Tuch; Eis nicht direkt auf die Haut legen.

Kontrollen und Fäden

Kontrolltermine werden nach Eingriff und Wundbefund festgelegt. Fäden werden häufig nach ein bis zwei Wochen entfernt, bei speziellen Wundverschlüssen auch später, etwa nach zwei bis drei Wochen. Oberflächlicher Wundverschluss ersetzt nicht die mehrmonatige Knochenheilung.

Arbeiten und Sport

Nach einfacher Implantation kann leichte Tätigkeit mitunter schon am Folgetag möglich sein. Bei umfangreichen Eingriffen oder körperlicher Arbeit kann etwa eine Woche oder mehr Schonung nötig sein. Sport und schwere körperliche Anstrengung in der frühen Heilungsphase vermeiden, häufig mindestens eine Woche; nach Aufbau gegebenenfalls länger. Die konkrete Freigabe richtet sich nach dem Verlauf.

Essen, Wärme und Genussmittel

Nicht auf die frisch operierte Region beißen; weiche Kost und ein druckfreies Provisorium schützen die Wunde. Am OP-Tag nicht kräftig spülen. Sauna, starke Wärme, Solarium und Alkohol zunächst meiden. Desinfizierende Spüllösung und Medikamente nur wie vereinbart verwenden. Dauermedikamente, insbesondere Blutverdünner und Diabetesmedikamente, nicht selbst ändern.

Rauchen

Rauchen verschlechtert die Voraussetzungen für Heilung und langfristigen Implantaterhalt. Wir empfehlen möglichst schon mindestens vier Wochen vor und vier Wochen nach dem Eingriff zu pausieren, besser dauerhaft aufzuhören. Die Pause ist keine Garantie für komplikationsfreie Heilung; Unterstützung beim Aufhören kann hilfreich sein.

Reisen und Verkehrstüchtigkeit

Wundkontrollen müssen möglich bleiben. Fernreisen mit eingeschränkter medizinischer Versorgung sollten in den ersten vier bis sechs Wochen nach dem Eingriff möglichst vermieden beziehungsweise vorher abgestimmt werden. Nach Sinuslift gelten eigene Regeln zum Fliegen und Tauchen. Nach Sedierung oder Narkose sind Abholung aus der Praxis und die vereinbarte Verkehrspause verpflichtend.

Implantatfreilegung – von der Einheilung zum Zahnersatz

Die Freilegung gehört zum Behandlungsablauf, wenn das Implantat geschützt unter dem Zahnfleisch eingeeilt ist. Sie macht das Implantat zugänglich und bereitet das Zahnfleisch auf die spätere Krone, Brücke oder Prothese vor. Dabei wird noch kein fertiger Zahn eingesetzt.

So läuft die Freilegung ab

- Zunächst prüfen wir, ob das Implantat stabil eingeeilt ist. Bringen Sie Ihren Implantatpass oder vorhandene Unterlagen mit.
- Der meist kleine Eingriff erfolgt in der Regel in örtlicher Betäubung. Die Schleimhaut wird gezielt eröffnet und eine Einheilkappe beziehungsweise ein Gingivaformer eingesetzt.
- Der Gingivaformer formt den Durchtritt durch das Zahnfleisch. Nach der Weichgewebeheilung – häufig etwa vier Wochen – geben wir die prothetische Weiterbehandlung frei.
- Ihre Hauszahnarztpraxis übernimmt anschließend Scan oder Abdruck und den Zahnersatz. Falls genäht wurde, werden die Fäden meist nach ein bis zwei Wochen entfernt; den Termin vereinbaren wir individuell.

Pflege und mögliche Beschwerden

Nachblutung, Schwellung, Druckgefühl, Infektion, Wundheilungsstörung oder ein Weichgewebsproblem sind möglich. Gelegentlich ist eine zusätzliche Schleimhautkorrektur erforderlich. Arbeitsfähigkeit und Schonung richten sich nach Umfang und Betäubung.

Die Region sauber halten, ohne die Wunde zu reizen. Nicht an der Einheilkappe drehen oder ziehen. Ein Provisorium darf nicht drücken. Bei Lockerung, Druckstellen, zunehmenden Schmerzen oder Schwellung, Eiter oder anhaltender Blutung melden Sie sich bitte bei uns.

Betäubung, Risiken und Kosten

Die konkrete Behandlung, Ihre persönlichen Risiken, Alternativen und die Kosten werden vor der Entscheidung mit Ihnen besprochen. Eine erfolgreiche Einheilung oder lebenslange Funktion kann nicht garantiert werden.

Betäubung und Komfortoptionen

Standard ist die Lokalanästhesie. Sie bleiben wach und können Druck oder Bewegung wahrnehmen. Bei Schmerzen unterbrechen wir und betäuben nach. Sedierung und Vollnarkose erfordern eine eigene anästhesiologische Beurteilung und Aufklärung.

Methode	Ablauf und wichtige Regeln	Kosten
Lokalanästhesie Standard	Örtliche Betäubung, wach. Heimfahrt mit ÖPNV ist möglich; die individuelle Verkehrsfähigkeit wird beurteilt.	Im chirurgischen Behandlungspaket berücksichtigt.
Orale Sedierung Tavor	Tablette meist etwa 60 Minuten vorher, Stressreduktion ohne zugesicherten Schlaf. Vitalüberwachung. Begleitperson und Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Ca. 80 € Eigenleistung.
Dämmerschlaf intravenös	Bei Implantationen in unserer Praxis in der Regel nicht angeboten; kleine Implantatteile und Husten-/Würgereiz können ein Aspirationsrisiko darstellen. Nur nach individueller Prüfung mit Narkoseteam. Falls vereinbart: dienstags, Aufwachraum und Vitalüberwachung, Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Nur Ausnahmefälle; Kosten vorher vereinbaren.
Vollnarkose	Tiefschlaf mit Atemwegssicherung, üblicherweise Beatmung über einen durch die Nase eingeführten Tubus. Narkoseteam dienstags, überwachte Aufwachphase. Abholung aus der Praxis verpflichtend; 24 Stunden nicht verkehrsfähig.	Zeitabhängig meist ca. 500–800 € zusätzliche Narkosekosten.

Für die meisten einfachen Implantationen reicht die örtliche Betäubung. Für Dämmerschlaf oder Vollnarkose gelten die konkreten Nüchternheitsvorgaben des Narkoseteams. In unserem üblichen Ablauf: ab 22 Uhr nichts essen, ab 6 Uhr nichts trinken; abweichende individuelle Vorgaben gehen vor. Medikamente nur wie vereinbart einnehmen.

Risiken der Betäubung

Möglich sind Kreislaufreaktionen, Blutergüsse, allergische Reaktionen und selten Nervenreizungen bei örtlicher Betäubung. Sedierung und Narkose können Atmung und Kreislauf beeinträchtigen sowie Übelkeit, Erbrechen oder Aspiration verursachen; selten sind schwere Komplikationen möglich. Deshalb sind Überwachung, passende Auswahl und verbindliche Begleit- und Nüchternheitsregeln wichtig.

Mögliche Risiken der Implantatbehandlung

- Schmerzen, Schwellung, Bluterguss und eingeschränkte Mundöffnung; außerdem Nachblutung, Infektion, Nahtöffnung und Wundheilungsstörung. Eine Infektion kann lokale Behandlung, gegebenenfalls Antibiotika oder einen weiteren Eingriff erfordern; Arzneimittel können Unverträglichkeiten oder Allergien auslösen.
- Fehlende Einheilung oder späterer Implantatverlust. Nach Abheilung kann eine erneute Versorgung möglich sein; manchmal sind zusätzliche Maßnahmen oder eine andere Lösung erforderlich.
- Schädigung von Nachbarzähnen oder Nerven: Taubheit, Kribbeln oder veränderte Empfindung an Lippe, Kinn oder Zunge können vorübergehend, selten dauerhaft bleiben. Betroffen sind vor allem Gefühlsnerven; eine solche Gefühlsstörung ist nicht mit einer sichtbaren Gesichtslähmung gleichzusetzen. Je nach Zugang können weitere sensible Strukturen betroffen sein.
- Im Oberkiefer: Eröffnung oder Entzündung der Kieferhöhle, gegebenenfalls Mund-Antrum-Verbindung (MAV); sehr selten Verlagerung eines Implantats in die Kieferhöhle. Bei Bedarf erfolgt eine HNO-Mitbeurteilung.
- Später können Schleimhautrückgang, sichtbare Implantatanteile, Entzündungen am Implantat, Schraubenlockerung oder Schäden an Implantat und Zahnersatz auftreten. Sehr selten sind Implantat- oder Kieferfrakturen sowie Verschlucken/Aspiration kleiner Teile möglich.
- Bei zusätzlichem Knochenaufbau bestehen weitere verfahrensabhängige Risiken, etwa Materialverlust oder Beschwerden an einer Entnahmestelle.

Rauchen, unzureichende Hygiene, unbehandelte Parodontitis, schlecht eingestellter Diabetes und bestimmte Medikamente erhöhen Risiken. Bei Bisphosphonaten/Denosumab oder vorausgegangener Bestrahlung beachten wir insbesondere das Risiko einer Kieferknochennekrose. Die persönliche Bedeutung dieser Faktoren besprechen wir vor einer Therapieentscheidung.

Kosten transparent planen

Erstberatung: Je nach Aufwand und notwendigen Untersuchungen bis zu 150 €; die implantologische Beratung wird in unserer Praxis als Eigenleistung angeboten. **DVT, falls erforderlich:** je nach Fragestellung 180–280 €. Die konkrete Abrechnung wird vorab erläutert.

Für Implantation, gegebenenfalls Knochenaufbau, Freilegung und optionale Anästhesie erhalten Sie eine individuelle Kostenaufstellung. Die Hauszahnarztpraxis berechnet Aufbau, Krone, Brücke oder Prothese separat. Der verbindliche Plan wird nach ausreichender Diagnostik erstellt; eine DVT ist dafür nicht pauschal bei jedem Patienten Voraussetzung.

Gesetzliche Krankenkassen übernehmen die Implantatchirurgie in der Regel nicht; seltene gesetzliche Ausnahmeindikationen werden gesondert geprüft. Für den Zahnersatz kann ein befundbezogener Festzuschuss möglich sein. Erstattung durch private Versicherung, Zusatzversicherung oder Beihilfe hängt vom individuellen Vertrag und den geltenden Regeln ab. Reichen Sie Kostenpläne vor Behandlungsbeginn zur Prüfung ein.

Auch bei korrekter Behandlung kann ein Implantat verloren gehen. Ursache, weitere Behandlung und mögliche Zusatzkosten werden im Einzelfall geklärt; daraus folgt weder automatisch eine Kostenfreiheit noch eine Bewertung als Behandlungsfehler.

Langfristiger Erhalt und Pflege

Die Heilung schützen

Beißen Sie nicht auf den frisch operierten Kieferkamm. Essen Sie weiche Kost und vermeiden Sie Druck durch harte Nahrung oder ein Provisorium. Reinigen Sie die übrigen Zähne sorgfältig; die Wundregion und eine gegebenenfalls verordnete desinfizierende Spüllösung behandeln Sie nach unserer Anleitung. Rauchen vermeiden, Kontrollen wahrnehmen und bei Problemen frühzeitig Kontakt aufnehmen. Den ausführlichen Nachsorgebogen erhalten Sie für die Zeit nach der Operation.

Pflege und Kontrollen ergänzen sich

Implantate können viele Jahre funktionieren. Ihre Haltbarkeit hängt von Ausgangssituation, Behandlung, Zahnersatz, Hygiene und Nachsorge ab. Reinigen Sie täglich gründlich mit Zahnbürste und geeigneten Hilfsmitteln für die Zwischenräume. Interdentalbürsten oder spezielle Zahnseide werden an die Versorgung angepasst. Professionelle Reinigung und zahnärztliche Kontrollen erfolgen risikoorientiert; eine Munddusche ersetzt die mechanische Reinigung nicht.

Nach chirurgischer Implantatversorgung kontrollieren wir in den ersten zwei Jahren jährlich Knochen, Schleimhaut, Hygiene, Pflegbarkeit und Stabilität der Konstruktion. Bei stabilen Verhältnissen können die chirurgischen Intervalle danach verlängert werden. Das ersetzt nicht die laufende Betreuung beim Hauszahnarzt. Bei Entzündung, erhöhtem Risiko oder nach Periimplantitis-Therapie sind engmaschigere Kontrollen nötig. Röntgenbilder erfolgen nach Indikation.

Der chirurgische Implantat-Recall kostet je nach Aufwand und Untersuchung bis zu 110 €. Dies ist kein Preis für eine gegebenenfalls erforderliche Periimplantitis-Behandlung.

Wann Sie sich melden sollten

Zunehmende Schmerzen oder Schwellung, anhaltende Blutung, Eiter, Fieber, neue oder anhaltende Gefühlsstörungen sowie ein lockeres Implantat oder ein wackelnder Zahnersatz müssen beurteilt werden. Eine lockere Krone kann auch auf eine Schraubenlockerung hinweisen: nicht weiter belasten und zeitnah kontrollieren lassen.

Praxis: 06151 786540. Nach einem Eingriff außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst 01805 60 70 11. Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge: 112.

Haltbarkeit, Knirschen und häufige Fragen

Wie lange hält ein Implantat?

Viele Implantate funktionieren über viele Jahre. Eine systematische Übersicht ermittelte nach zehn Jahren etwa 96 % erhaltene Implantate; eine vorsichtiger Auswertung unter Berücksichtigung fehlender Nachbeobachtungen etwa 93 %. Diese Gruppenwerte sind keine individuelle Prognose und bedeuten nicht, dass alle Implantate beschwerde- oder reparaturfrei geblieben sind. Knochen, Zahnfleisch, Pflege, Rauchen, Belastung und Nachsorge beeinflussen das Ergebnis. [1]

Was bedeutet Knirschen oder Pressen?

Hohe wiederholte Kräfte können Schrauben, Implantataufbau und Zahnersatz belasten. Bitte berichten Sie über Knirschen, Pressen oder frühere Brüche. Wir berücksichtigen dies bei Planung und Belastung; nach Abschluss der Versorgung kann eine individuell angepasste Aufbisschiene beim Hauszahnarzt sinnvoll sein. Sie ersetzt weder die richtige Einstellung des Bisses noch regelmäßige Kontrollen.

Wie wird dauerhaft gereinigt?

Mindestens zweimal täglich gründlich putzen und die Implantatzwischenräume mit passenden Interdentalbürsten oder spezieller Zahnseide reinigen. Entscheidend ist eine sorgfältige Technik, die wir beziehungsweise Ihre Hauszahnarztpraxis zeigen. Eine Munddusche kann ergänzen, ersetzt aber keine mechanische Reinigung. Professionelle Reinigung ist häufig zwei- bis dreimal jährlich sinnvoll; das Intervall wird nach Risiko angepasst und kann kürzer sein.

Was ist eine Periimplantitis?

Eine Entzündung um das Implantat kann anfangs wenig Beschwerden machen. Bei Periimplantitis ist auch der stützende Knochen betroffen. Häufigkeitsangaben unterscheiden sich je nach Definition, Beobachtungsdauer und Risikoprofil; eine einzige Prozentzahl beschreibt Ihr persönliches Risiko nicht zuverlässig. Frühzeitige Kontrolle und Behandlung sind wichtig. [3]

Was geschieht, wenn das Implantat nicht einheilt?

Wir klären Ursache, Knochenangebot und Alternativen. Nach Entfernung und ausreichender Abheilung kann eine erneute Implantation möglich sein, häufig erst nach mehreren Monaten, beispielsweise drei bis sechs Monaten; mit zusätzlichem Aufbau gegebenenfalls später. Behandlung und Kosten werden neu besprochen. Aus einem Verlust allein lässt sich weder automatisch ein Behandlungsfehler noch Kostenfreiheit ableiten.

Wie lange dauert die Operation?

Bei einem unkomplizierten Einzelimplantat kann die chirurgische Behandlung etwa 20–30 Minuten benötigen; der gesamte OP-Termin kann etwa 30–60 Minuten oder länger dauern. Vorbereitung, Betäubung, Zahl der Implantate und Aufbaumaßnahmen beeinflussen die Dauer. Für Ihren Fall nennen wir den geplanten Zeitrahmen.

Wer übernimmt welche Leistung und welche Kosten?

MKG im Carree

Wir übernehmen die implantologische Beratung und chirurgische Planung, erforderliche Diagnostik einschließlich einer gegebenenfalls nötigen DVT, Implantatinserterion, Knochenaufbau oder Sinuslift, Freilegung und chirurgische Nachkontrollen. Gewünschte Sedierung oder Narkose wird zusätzlich geplant und abgerechnet. Die Hauszahnarztpraxis erhält die erforderlichen Informationen zur chirurgischen Behandlung und zur prothetischen Freigabe.

Ihre Hauszahnarztpraxis

Dort werden Scan beziehungsweise Abformung, Laborarbeiten, prothetisches Abutment, Krone, Brücke oder Prothese, Eingliederung, Bisskontrolle und die laufende Betreuung der Prothetik geplant und separat abgerechnet. Die Abstimmung beginnt bereits beim gewünschten Zahnersatz vor der Operation. Sie erhalten deshalb getrennte Kostenpläne beziehungsweise Rechnungen.

Gesetzliche und private Versicherung

Implantatchirurgie ist bei gesetzlich Versicherten in der Regel eine Eigenleistung; gesetzliche Ausnahmeindikationen werden gesondert geprüft. Für den Zahnersatz kann ein befundbezogener Festzuschuss möglich sein, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Bonushefts. Bei privater oder Zusatzversicherung hängt die Erstattung vom Tarif ab. Reichen Sie die Pläne möglichst vor Behandlungsbeginn ein und klären Sie den verbleibenden Eigenanteil.

Beihilfe

Auch bei Beihilfe ist nicht automatisch die gesamte Rechnung erstattungsfähig. Nach der Bundesbeihilfeverordnung gelten grundsätzlich 50 % für aktive Beihilfeberechtigte, 70 % unter anderem für Versorgungsempfänger und berücksichtigungsfähige Ehe- oder Lebenspartner sowie 80 % für berücksichtigungsfähige Kinder. Für Berechtigte mit mindestens zwei berücksichtigungsfähigen Kindern kann der Satz ebenfalls 70 % betragen. Persönliche Voraussetzungen, Leistungsbegrenzungen, Bundes- oder Landesrecht und gegebenenfalls besondere Regelungen etwa für Soldaten sind zu beachten. Die Prozentsätze beziehen sich auf beihilfefähige Aufwendungen, nicht zwingend auf die gesamte Implantatrechnung. Verbindlich ist die Auskunft Ihrer Beihilfestelle. [4]

Wann wird der Plan verbindlich?

Eine grobe Einschätzung ist beim Erstgespräch möglich. Den konkreten Behandlungs- und Kostenplan erstellen wir nach ausreichender Diagnostik; nicht jeder Fall benötigt dafür eine DVT. Zusätzlicher Aufbau, besondere Provisorien oder eine Änderung des Befunds können eine Anpassung erforderlich machen.

Rückfragen und fachliche Quellen

Wann sollten Sie sich rasch melden?

Anhaltende Blutung trotz etwa 30 Minuten vorsichtigem Druck mit einer sauberen Kompresse, Fieber über 38,5 °C oder anhaltendes Fieber, zunehmende Schwellung nach Tag drei bis vier, Eiter, fauliger Geschmack oder Geruch, Lockerung und anhaltende Taubheit müssen beurteilt werden. Diese Beispiele sind keine Aufforderung abzuwarten: Bei starken oder rasch zunehmenden Beschwerden früher melden. Bei Atemnot oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge sofort 112.

MKG im Carree: 06151 786540 · info@mkg-im-carree.de

Postoperativ außerhalb der Praxissprechzeiten: +49 151 10437450. Falls nicht erreichbar: 01805 60 70 11.
Lebensbedrohlicher Notfall: 112.

[1] [Howe et al. 2019 · Long-term \(10-year\) dental implant survival](#)

[2] [ITI 2023 · Clinical and radiographic outcomes of zirconia dental implants](#)

[3] [European Federation of Periodontology · Peri-implant diseases](#)

[4] [Bundesbeihilfeverordnung · § 46](#)

[5] [Cambridge University Hospitals · Insertion of dental implants](#)

[6] [ITI · Implant placement and loading protocols](#)